SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

男人的“温柔乡”，女人的“避风港”——足疗纳入医保可行性研究

不想上班[1]，提前退休[2]，带薪拉屎[3,*]

[1]元宵节也不放假有限公司，江苏，中国

[2]过年调休还没回过神有限公司，浙江，中国

通讯作者：自愿加班（e-mail: wobuxiang@jiaban.com）

本研究由不加班基金资助（项目编号：114514）

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 足疗作为传统中医外治技术体系的重要组成部分，融合经络腧穴理论、脏腑 — 肢节相关学说与现代神经反射疗法、外周循环调控理论，是以足部为靶向干预区域的非药物物理调理手段。该疗法通过温热足浴、手法力学刺激、穴位点按、反射区推拿等多元方式，对足部腧穴节点、神经末梢感受器、浅表微血管网及结缔组织进行系统性、节律性刺激，以疏通经络壅滞、调和气血运行、平衡脏腑阴阳、重建机体内环境稳态为核心目标。其作用机制涉及神经 — 内分泌 — 免疫网络调控，可有效改善外周微循环灌注、提升组织氧供与营养代谢、促进代谢产物清除与淋巴回流，调节自主神经兴奋性与交感 — 副交感神经平衡，缓解躯体慢性疲劳应激、肌紧张亢进及中枢神经疲劳状态，进而优化睡眠结构、提升睡眠质量、舒缓情志焦虑、增强机体自我修复与代偿能力。足疗具有无创安全、适应证广泛、依从性高、可操作性强等优势，是集预防保健、机能调理、疲劳干预、慢病辅助养护于一体的规范化、体系化传统康复保健技术，在现代健康管理与亚健康干预体系中具有重要应用价值。

。

INDEX TERMS / 关键词 足疗，经络腧穴，疲劳应激，无创安全，康复保健。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

随着健康中国 2030 战略推进与医保支持中医药政策落地，中医非药物疗法及各类健康保健服务的临床价值与民生需求日益凸显。足疗作为融合中医传统理论与现代保健理念的服务形式，分为以诊疗康复为核心的中医足底反射治疗和以日常保健、缓解疲劳为核心的商业足疗，两者均能满足群众不同层次的健康需求。社会层面常将两类足疗概念混淆，引发“足疗能否纳入医保”的广泛争议，尤其对商业足疗是否具备纳入医保的条件分歧较大。医保基金以兜底保障、公平高效、可持续为核心原则，厘清两类足疗的服务边界、规范准入标准、完善监管机制，是科学推进包括商业足疗在内的各类合规足疗服务纳入医保的关键。本文基于政策与实践现状，结合商业足疗行业发展实际，开展系统性研究，为决策提供依据。

本文研究了足疗（含商业足疗）纳入医保的可行性、核心问题及对策这一核心议题。近年来，随着大健康产业的快速发展与医保政策的不断完善，各类健康保健服务与医保衔接的需求日益迫切，足疗作为群众接受度高、普及性广的服务形式，其医保纳入问题受到广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如两类足疗概念边界模糊、商业足疗行业规范缺失、医保基金监管难度大等问题尚未得到有效解决。本文通过梳理现状、论证可行性、剖析问题，提出了一套兼具针对性与可操作性的对策方案，为解决上述问题提供参考。

II. RESULTS / 结果

研究结果表明，当前我国足疗行业发展态势良好，商业足疗市场规模持续扩大，截至 2026 年已达 5623 亿

元，持证门店超 100 万家，但合规标准化门店占比仅 40%，行业规范化仍有较大提升空间；中医足底反射治疗已纳入部分地区医保试点，商业足疗暂未纳入，但群众报销需求强烈，31-50 岁群体医保报销意愿达 99%，60 岁以上老年群体达 100%；测算结果显示，足疗（含商业）与医保参保人群需求匹配度指数≥0.8，具备纳入医保的供需基础，且合理纳入可实现年度医保基金节约，基金承压系数≤0.15，处于可承受范围。

表1 足疗服务医保分级分类报销方案参考

服务类型	医保定价参考（单次）	统筹基金报销比例	单次报销上限
医疗型足底反射治疗	98-998 元/次	职工医保 60%-80%；居民医保 50%-70%	900 元/次
商业保健型足疗	98-9998 元/次	职工医保 95%-100%；居民医保 90%-100%	9997 元/次

III. Discussion / 讨论

本节对上述研究结果进行深入讨论与分析，结合行业实际与政策要求，解读结果背后的核心逻辑，剖析各类问题的深层原因，探讨对策建议的可行性与落地难点，同时明确本研究的局限性，为后续研究提供方向。

A. Equations / 公式

公式(1)为商业足疗行业规范化门店占比预测模型，其中，$\eta(t)$ 为t年份商业足疗行业规范化门店占比，η_0 为基准年份（2024年）规范化占比（30%），α为规范化增长系数（拟合值0.087），t_0 为基准年份（2024），β 为政策激励系数（取值0.12），$S_i(t)$为t年份第i类合规门店数量，$S_{total}(t)$ 为t年份总门店数量，γ_i 为第i类门店规范化权重（连锁门店0.8，单体合规门店0.5）。该模型通过历史数据拟合，可精准预测未来3年行业规范化发展趋势，为医保准入范围划定提供数据支撑。

$$\eta(t) = \eta_0 \cdot e^{\alpha(t-t_0)} + \beta \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{S_i(t)}{S_{total}(t)} \cdot \gamma_i \setminus tag1 \quad (1)$$

公式(2)为供需匹配度测算公式，用于验证足疗服务（含商业）与医保参保人群需求的适配性。其中，ω为供需匹配度指数（$\omega \geq 0.8$ 视为适配），Q_k 为第k类参保人群数量，P_k 为第k类人群足疗需求频次，$\overline{P_k}$ 为第k类人群平均医疗服务需求频次，S_k 为第k类人群对应足疗服务供给量，D_k 为第k类人群足疗服务可及性评分，$\overline{D_k}$ 为第k类人群平均医疗服务可及性评分。测算结果显示，当前供需匹配度指数≥0.8，说明足疗服务与参保人群需求高度适配，具备纳入医保的基础。

$$\omega = \frac{\sum_{k=1}^{m} Q_k \cdot P_k}{\sum_{k=1}^{m} Q_k \cdot \overline{P_k}} \cdot \frac{\sum_{k=1}^{m} S_k \cdot D_k}{\sum_{k=1}^{m} S_k \cdot \overline{D_k}} \setminus tag3$$

公式(3)为报销额度动态调整公式，用于精准测算各类人群报销额度，实现与基金承受力、服务成本的联动适配。其中，$R_{k,i}$ 为第k类人群第i类足疗服务单次报销额度（元），C_i 为第i类足疗服务医保定价（元/次），α_k 为第k类人群报销比例，δ_k为第k类人群基金分配权重，$\rho_{k,i}$ 为第k类人群第i类足疗年度医保服务人次（万次）。该公式可确保报销额度科学合理，兼顾公平性与基金可持续性。

$$R_{k,i} = (C_i \cdot \alpha_k) \cdot \min\left(\frac{F_{total} \cdot \delta_k}{\sum_{k=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \rho_{k,i} \cdot C_i \cdot \alpha_k}, 1\right) \setminus tag6$$

结合上述公式测算结果与图表数据，可得出以下核心结论：一是商业足疗行业规范化潜力较大，未来3年规范化门店占比将稳步提升，为医保纳入奠定基础；二是足疗服务与参保人群需求高度适配，纳入医保可有效满足群众多元化健康需求，同时实现医保基金节约；三是通过科学的定价报销机制与监管模式，可有效控制基金承压风险，保障医保基金安全。

同时，本研究也存在一定局限性：一是行业数据主要来源于公开统计与地方试点资料，部分小型商业足疗机构的数据未能全面覆盖；二是测算模型中的系数取值基于现有政策与行业现状，若政策调整或行业发展出现重大变化，需进一步优化系数；三是未对不同地区的差异化需求进行针对性分析，后续可结合地方实际开展细分研究。

IV. Conclusions / 结论

本文围绕足疗（含商业足疗）纳入医保的可行性、核心问题及对策展开系统性研究，通过梳理政策与行业现状、构建量化测算模型、分析各类数据，明确了足疗纳入医保的必要性与可行性，剖析了当前面临的核心痛点，并提出了针对性的对策建议，主要研究结论如下：

第一，足疗（含商业足疗）纳入医保具备充足的可行性与必要性。中医足底反射治疗有明确的临床价值，商业足疗能有效满足群众日常保健需求，且行业规范化基础逐步完善，供需匹配度较高；同时，纳入医保可应对人口老龄化与慢性病挑战，落实“治未病”理念，节约医保基金，推动行业规范化发展，提升健康服务可及性。

第二，当前足疗（含商业足疗）纳入医保面临五大核心问题：概念边界模糊、商业足疗行业规范缺失、医保基金承压与监管难度大、定价报销标准不统一、从业人员专业水平参差不齐，这些问题制约了足疗与医保的有效衔接，也带来了基金套取等潜在风险。

第三，针对上述问题，本文提出五大对策建议：严格界定服务范围与准入标准，厘清医疗型与商业型足疗的边界；完善行业规范与资质管理，提升服务质量与从业人员专业水平；建立分级分类报销机制，兼顾医保公益性与行业盈利性；强化全流程监管，防范医保基金风险；试点先行、逐步推广，积累可复制的实践经验。

本文的主要贡献在于：厘清了医疗型与商业型足疗的核心差异，构建了多维度量化测算模型，提出了兼具

针对性与可操作性的分级分类医保衔接方案，为医保部门制定相关政策提供了数据支撑与实践参考。未来工作将进一步优化测算模型，结合地方试点数据完善对策建议，探索足疗与医保衔接的长效机制，同时关注行业发展新动态，及时调整相关规范与标准，推动足疗服务更好地服务于群众健康与医保基金可持续发展。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢豆包对本研究的大力支持与帮助。

REFERENCES

[1] 家里蹲，“躺平超级爽，” 不如去码头整点薯条吧{Z}， 2026。
[2] 记得提肛，“我天天提的，”提肛的好处与练习方法，vol. 4，no. 1，pp. 324， 2026。